



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
SISI YANG BENAR, PROSEDUR YANG
BENAR
PASIEN YANG BENAR PADA PEMBEDAHAN/
TINDAKAN INVASIF
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 633.16/I-PND/DIR/VII/2025

Tentang
Panduan Sisi Yang benar, Prosedur Yang Benar, Pasien Yang Benar Pada Pembedahan/
Tindakan Invasif

Disusun oleh :
Penanggung jawab BAB SKP



(Khusnul Khotimah, S. Kep, Ns.)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 633.16/I-PND/DIR/VII/2025**

TENTANG

**PANDUAN SISI YANG BENAR, PROSEDUR YANG BENAR, PASIEN YANG BENAR
PADA PEMBEDAHAN/ TINDAKAN INVASIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsif terhadap kejadian tidak diinginkan di fasilitas pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali;
- b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada dapat melaksanakan dengan baik perlu adanya peraturan direktur tentang panduan penandaan lokasi sisi operasi/ invasif
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit tentang Panduan Sisi Yang Benar, Prosedur Yang Benar, Pasien Yang Benar Pada Pembedahan/ Tindakan Invasif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PANDUAN SISI YANG BENAR, PROSEDUR YANG BENAR, PASIEN YANG BENAR PADA PEMBEDAHAN/ TINDAKAN INVASIF**

Pasal 1

- (1) Tindakan operasi dan invasive meliputi semua tindakan yang melibatkan insisi atau pungsi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, operasi terbuka, aspirasi perkutan, injeksi obat tertentu, biopsi, tindakan intervensi atau diagnostic vaskuler dan kardial perkutan, laparaskopi, ekstraksi gigi, ESWL, dan endoskopi.
- (2) Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien
- (3) Penandaan lokasi tindakan operasi/ invasive dilakukan oleh PPA yang akan melakukan tindakan tersebut
- (4) PPA tersebut akan melakukan seluruh prosedur operasi/ invasive dan tetap berada dengan pasien selama tindakan berlangsung

Pasal 2

- (1) Pada tindakan operasi, dokter operator/ dokter penanggung jawab pasien (DPJP) bedah akan melakukan tindakan penandaan lokasi
- (2) Tindakan invasive non-operasi, penandaan dilakukan oleh dokter yang akan melakukan tindakan
- (3) Penandaan dapat dilakukan di area luar kamar operasi

Pasal 3

- (1) Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien serta dengan tanda yang tidak memiliki arti ganda serta segera dapat dikenali
- (2) Tanda harus terlihat sampai pasien disiapkan
- (3) Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan (lateralisasi), struktur multiple (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multiple level (tulang belakang)

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang Nomor 488/I-PER/DIR/VI/2018 tentang Panduan Penandaan Lokasi Operasi Dan Tindakan Invasif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 1 Juli 2025
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan KaruniaNya Panduan Sisi Yang benar, Prosedur Yang Benar, Pasien Yang Benar Pada Pembedahan/ Tindakan Invasif dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Panduan Sisi Yang benar, Prosedur Yang Benar, Pasien Yang Benar Pada Pembedahan/ Tindakan Invasif ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi penandaan yang ditandai semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan, harus melibatkan pasien.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Sisi Yang benar, Prosedur Yang Benar, Pasien Yang Benar Pada Pembedahan/ Tindakan Invasif ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 1 Juli 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PANDUAN SISI YANG BENAR, PROSEDUR YANG BENAR, PASIEN YANG BENAR PADA PEMBEDAHAN/ TINDAKAN INVASIF

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Pelaksana

1. dr. Nurmazidah
2. Indah Maulhayati, S. Kep. Ns
3. Artika Wulandari, S. Kep. Ns
4. Siti Durotul Ibadiah, S. Kep. Ns
5. Fadhila Ayu Setyani, S. Kep. Ns
6. Afni Nur Ainy, S. Kep. Ns
7. Khusnul Khotimah, S. Kep. Ns
8. Wiwit Indah Yanti, S. Kep. Ns
9. Very Susanto, S. Kep. Ns
10. Murwani Suryaning S, S. Kep, Ns
11. Sherly Rosita, S. Kep, Ns
12. Dan seluruh staf di RS Prima Husada Malang

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN	ii
PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA	iii
KATA PENGANTAR	iv
TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Sasaran	1
1.4. Pengertian	2
BAB II RUANG LINGKUP	3
BAB III TATA LAKSANA	4
BAB IV DOKUMENTASI	6
BAB V PENUTUP	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lembar Formulir Penandaan Area Operasi	
Dokumen Rekam Medis Penandaan Area Operasi	6

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR 633.16/I-PND/DIR/VII/2025
TENTANG
PANDUAN SISI YANG BENAR,
PROSEDUR YANG BENAR, PASIEN YANG
BENAR PADA PEMBEDAHAN/
TINDAKAN INVASIF

**PANDUAN SISI YANG BENAR, PROSEDUR YANG BENAR, PASIEN YANG BENAR PADA
PEMBEDAHAN/ TINDAKAN INVASIF**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Pembedahan merupakan salah satu tindakan medis yang penting dalam pelayanan kesehatan. Tindakan pembedahan merupakan salah satu tindakan medis yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan dan komplikasi. Namun demikian, pembedahan yang dilakukan juga menimbulkan komplikasi yang dapat membahayakan nyawa.

Rumah sakit wajib mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ tindakan invasive. Salah-sisi, salah-prosedur, salah-pasien operasi, adalah kejadian yang mengkhawatirkan dan dapat terjadi di rumah sakit. Kesalahan ini terjadi akibat adanya komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurangnya keterlibatan pasien di dalam penandaan operasi (*site marking*), serta tidak adanya prosedur untuk memverifikasi sisi operasi.

Menurut *surgical safety checklist* WHO : penandaan area operasi merupakan kunci utama dalam menciptakan keselamatan pasien sebelum operasi. Penandaan area operasi merupakan hal yang paling penting untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian saat operasi, akibat salah insisi, salah pasien, dan salah letak.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Maksud disusunnya Panduan Penandaan Lokasi Sisi Operasi/ Invasif adalah untuk digunakan sebagai panduan atau acuan bagi seluruh staf rumah sakit dalam penandaan pasien yang menjalani tindakan operasi/ invasif.
2. Tujuan
 - a. Terjadinya proses penandaan sisi operasi/ invasive sebelum tindakan dilakukan
 - b. Verifikasi terhadap sisi yang benar, prosedur yang benar dan pasien yang benar terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku
 - c. Tidak terjadi kesalahan tindakan jika penandaan sisi operasi/ invasive tidak dilakukan

1.3. SASARAN

Sasaran Panduan Sisi Yang Benar, Prosedur Yang Benar, Pasien Yang Benar Pada Pembedahan/ Tindakan Invasif adalah operator bedah/ dokter penanggung jawab (DPJP) yang melakukan tindakan operasi/ invasif di Rumah Sakit Prima Husada.

1.4. PENGERTIAN

Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan (lateralisasi), struktur multiple (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multiple level (tulang belakang). Penandaan lokasi operasi harus melibatkan pasien dan dilakukan dengan tanda yang langsung dapat dikenali dan tidak bermakna ganda serta dapat berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penandaan lokasi operasi.

Tanda yang dibuat harus seragam dan konsisiten digunakan di rumah sakit. Dalam semua kasus yang melibatkan lateralitas, struktur ganda (jari tangan, jari kaki, lesi) atau tingkatan berlapis (tulang belakang), lokasi operasi harus ditandai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pemberian tanda di tempat dilakukan operasi atau prosedur invasif melibatkan pasien dan dilakukan dengan tanda yang tepat serta dapat dikenali. Tanda yang dipakai harus konsisten digunakan di semua tempat di rumah sakit, harus dilakukan oleh individu yang melakukan prosedur operasi, saat melakukan pasien sadar dan terjaga jika mungkin, serta harus masih terlihat jelas setelah pasien sadar. Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan (lateralisasi), struktur multiple (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multiple level (tulang belakang).

Verifikasi praoperasi merupakan proses pengumpulan informasi dan konfirmasi secara terus - menerus. Tujuan dari proses verifikasi praoperasi adalah :

1. Melakukan verifikais terhadap sisi yang benar, prosedur yang benar dan pasien yang benar
2. Memastikan bahwa semua dokumen, foto hasil radiologi atau pencitraan, dan pemeriksaan yang terkait operasi telah tersedia, sudah diberi label dan disiapkan
3. Melakukan verifikais bahwa produk darah, peralatan medis khusus dan/ atau implant yang diperlukan sudah tersedia

Beberapa elemen proses verifikasi praoperasi dapat dilakukan sebelum pasien tiba di tempat praoperasi, seperti memastikan dokumen, imaging, hasil pemeriksaan, dokumen lain diberi label yang benar, dan memberi tanda di tempat (lokasi) operasi.

Time-out dilakukan sesaat sebelum tindakan dimulai dan dihadiri semua anggota tim yang akan melaksanakan tindakan operasi. Selama *time-out*, tim menyetujui komponen, benar identitas pasien, benar prosedur yang akan dilakukan, benar sisi operasi/ tindakan invasife.

Salah-sisi, salah-prosedur, salah-pasien operasi, adalah kejadian yang mengkhawatirkan dan dapat terjadi di rumah sakit. Kesalahan ini terjadi akibat adanya komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurangnya keterlibatan pasien di dalam penandaan operasi (*site marking*), serta tidak adanya prosedur untuk memverifikasi sisi operasi.

BAB III

TATA LAKSANA

Rumah sakit memastikan dilaksanakannya proses *Time-out* di kamar operasi atau ruang tindakan sebelum operasi dimulai dengan memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, dan pasien yang benar. Kesalahan ini bisa terjadi diakibatkan:

1. Komunikasi yang tidak efektif dan tidak adekuat antar anggota tim
2. Tidak ada keterlibatan pasien untuk memastikan ketepatan lokasi operasi dan tidak ada prosedur untuk verifikasi
3. Asesmen pasien tidak lengkap
4. Catatan rekam medik tidak lengkap
5. Budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim
6. Masalah yang terkait dengan tulisan yang tidak terbaca, tidak jelas, dan tidak lengkap
7. Penggunaan singkatan yang tidak terstandarisasi dan dilarang.

Tindakan bedah dan prosedur invasif memuat semua prosedur investigasi dan atau memeriksa penyakit serta kelainan dari tubuh manusia melalui mengiris, mengangkat, memindahkan, mengubah atau memasukkan alat laparaskopi/ endoskopi ke dalam tubuh untuk keperluan diagnostik dan terapeutik.

Rumah sakit harus menentukan area-area di dalam rumah sakit yang melakukan tindakan bedah dan prosedur invasif. Sebagai contoh, kateterisasi jantung, radiologi intervensi, laparaskopi, endoskopi, pemeriksaan laboratorium, dan lainnya. Ketentuan rumah sakit tentang sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang berlaku di semua area rumah sakit di lokasi tindakan bedah dan invasif dilakukan. Rumah sakit diminta untuk menetapkan prosedur yang seragam sebagai berikut:

1. Proses verifikasi sebelum operasi
2. Penandaan sisi operasi
3. *Time-out* dilakukan sesaat sebelum memulai tindakan

Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien serta dengan tanda yang tidak memiliki arti ganda serta segera dapat dikenali. Tanda tersebut harus digunakan secara konsisten di dalam rumah sakit, dan harus dibuat oleh PPA yang akan melakukan tindakan, harus dibuat saat pasien terjaga dan sadar jika memungkinkan, dan harus terlihat sampai pasien disiapkan.

Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan (lateralisasi), struktur multiple (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multiple level (tulang belakang). Untuk beberapa hal dalam penandaan lokasi operasi dan tindakan invasif maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Penandaan harus dilakukan operator bedah, saat pasien dalam kondisi sadar. Penandaan dilakukan sebelum pasien dipindahkan ke kamar operasi dari ruang rawat inap. Penandaan area operasi yang dilakukan dapat membuat pasien lebih nyaman dan tenang, sebelum pasien dipindahkan ke ruang premedikasi.
2. Penandaan dilakukan dengan memberi tanda panah dan lingkaran(→○).
3. Penandaan dilakukan dengan menggunakan *surgical marking permanent* yang berwarna hitam, sehingga tetap terlihat setelah dilakukan desinfeksi dan *draping*.
4. Tata cara penandaan area operasi (site marking) :
 - a. Selamat pagi bapak/ibu/sdr/sdri... saya dokter
 - b. Tolong sebutkan nama dan tanggal lahir bapak/ibu/sdr/sdr
 - c. Dokter operator melakukan edukasi tindakan operasi dan melakukan penandaan area operasi (→○) dan inisial dokter operator. Penandaan lokasi operasi harus melibatkan pasien dan dibuat saat pasien masih sadar.
 - d. Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan (lateralisasi), struktur multiple (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multiple level (tulang belakang).

-
- e. Proses verifikasi praoperatif (sebelum insisi / “time out”) harus dilakukan dan didokumentasikan.
 - f. Penandaan area operasi pada daerah mata dengan menggunakan kasa/*gause* yang ditutupkan pada mata yang akan dioperasi.
5. Beberapa prosedur yang tidak memerlukan penandaan:
- a. Kasus organ tunggal (misalnya operasi jantung, operasi caesar).
 - b. Kasus intervensi seperti kateter jantung.
 - c. Kasus yang melibatkan gigi. Namun, penandaan dilakukan di foto panoramic dan di odontogram dalam dokumen rekam medis.
 - b. Prosedur yang melibatkan bayi prematur di mana penandaan akan menyebabkan tato permanen.

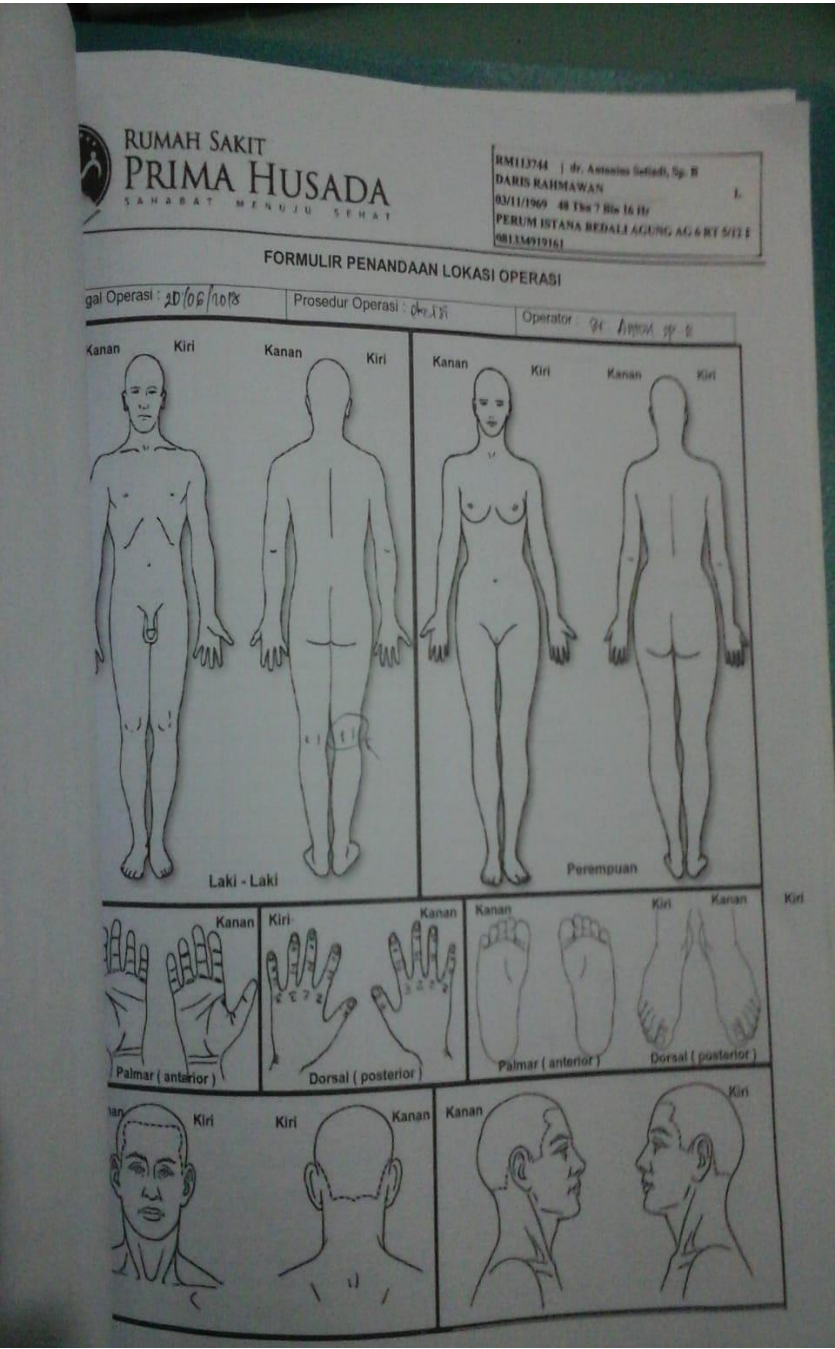
Dalam kasus – kasus di mana tidak dilakukan penandaan, alasan harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Sedapat mungkin penandaan harus melibatkan pasien untuk menghindarkan kekeliruan. Meskipun jarang, pasien boleh menolak penandaan setelah dijelaskan maksud dan tujuannya.

Penandaan harus dibuat menggunakan surgical marking pen yang tidak hilang bila dicuci saat preparasi lapangan operasi. Untuk pasien dengan warna kulit gelap, boleh digunakan warna selain hitam atau biru gelap (biru tua) agar penandaan jelas terlihat, misalnya warna merah. Jika terdapat beberapa prosedur dalam satu operasi, maka time-out harus dilakukan sebelum setiap prosedur. Prosedur tidak boleh dimulai sebelum tercapai kata sepakat oleh semua anggota tim (dalam time-out) atau sebelum semua pertanyaan atau masalah terjawab. Time-out ini harus terdokumentasikan, minimal berbentuk suatu pernyataan bahwa time-out telah dilakukan dan tercapai kata sepakat.

Sebelum operasi atau tindakan invasive dilakukan, rumah sakit menyediakan “check list” untuk mencatat, apakah informed consent sudah benar, apakah tepat – lokasi, tepat prosedur , tepat pasien sudah teridentifikasi.

BAB IV
DOKUMENTASI

Dalam pelaksanaannya pembuatan laporan penandaan didokumentasikan dalam :
1. Lembar formulir penandaan area operasi dokumen rekam medis penandaan area operasi

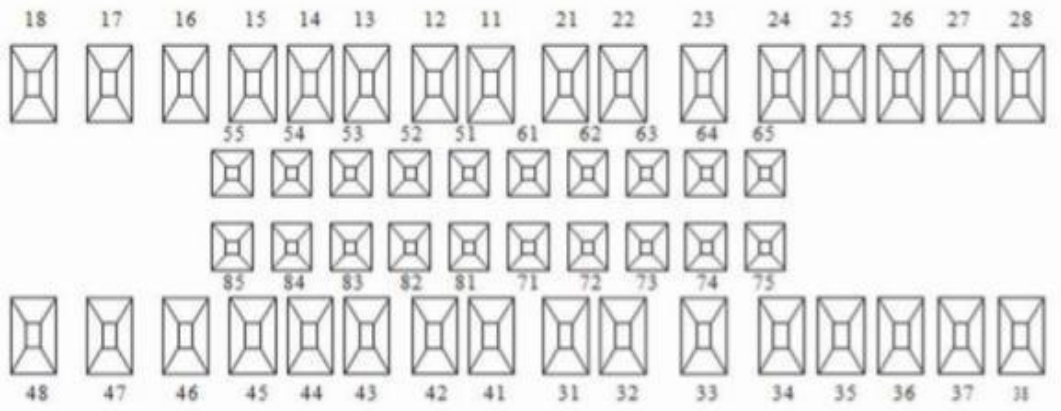


Gambar 4.1 Lembar formulir penandaan area operasi dokumen rekam medis penandaan area operasi

2. Lembar formulir rekam medik pendandaan gigi Poli Gigi dan Mulut

a. Formulir Pemeriksaan Odontogram (Anak)

11 (51)			(61) 21
12 (52)			(62) 22
13 (53)			(63) 23
14 (54)			(64) 24
15 (55)			(65) 25
16			26
17			27
18			28



48			38
47			37
46			36
45 (85)			(75) 35
44 (84)			(74) 34
43 (83)			(73) 33
42 (82)			(72) 32
41 (81)			(71) 31

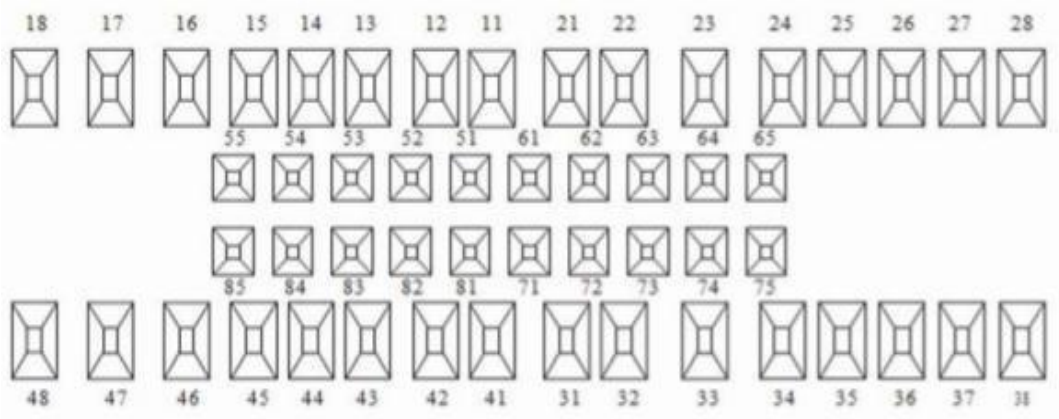
Occlusi : Normal Bite / Cross Bite / Steep Bite
Torus Palatinus : Tidak ada / Kecil / Sedang / Besar / Multiple
Torus Mandibularis : Tidak ada / Sisi Kiri / Sisi kanan /
Kedua Sisi Palatum : Dalam / Sedang / Rendah
Diastema : Tidak ada / Ada ; (dijelaskan dimana dan berapa lebarnya)
.....
Gigi Anomali : Tidak Ada / Ada ; (dijelaskan gigi yang mana, dan bentuknya)
.....
Lain-lain : (hal-hal yang tidak tercakup diatas)
.....

D : M : F :
Jumlah photo yang diambil(digital/intraoral)*
Jumlah rontgen photo yang diambil (Dental / PA /
OPG / Ceph)*

Diperiksa oleh :	Tanggal dan Jam Pemeriksaan	Tanda Tangan Pemeriksa	Tanda Tangan Keluarga Pasien
drg.....	Tanggal :...../...../..... Pukul :WIB	(.....)	(.....)

b. Formulir Pemeriksaan Odontogram (Dewasa)

11 (51)		(61) 21
12 (52)		(62) 22
13 (53)		(63) 23
14 (54)		(64) 24
15 (55)		(65) 25
16		26
17		27
18		28



48		38
47		37
46		36
45 (85)		(75) 35
44 (84)		(74) 34
43 (83)		(73) 33
42 (82)		(72) 32
41 (81)		(71) 31

Occlusi : Normal Bite / Cross Bite / Steep Bite
Torus Palatinus : Tidak ada / Kecil / Sedang / Besar / Multiple
Torus Mandibularis : Tidak ada / Sisi Kiri / Sisi kanan /
Kedua Sisi Palatum : Dalam / Sedang / Rendah
Diastema : Tidak ada / Ada ; (dijelaskan dimana dan berapa lebarnya)
.....
Gigi Anomali : Tidak Ada / Ada ; (dijelaskan gigi yang mana, dan bentuknya)
.....
Lain-lain : (hal-hal yang tidak tercakup diatas)
.....
D : M : F :
Jumlah photo yang diambil(digital/intraoral)*
Jumlah rontgen photo yang diambil (Dental / PA /
OPG / Ceph)*

Diperiksa oleh : drg.....	Tanggal dan Jam Pemeriksaan Tanggal :...../...../..... Pukul :WIB	Tanda Tangan Pemeriksa (.....)	Tanda Tangan Keluarga Pasien (.....)
----------------------------------	---	---	--

BAB V PENUTUP

Sasaran Keselamatan Pasien yang wajib diterapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Rumah Sakit berperan penting dalam proses tidak adanya pasien dalam tindakan salah-sisi, salah-prosedur, salah-pasien operasi. Rumah Sakit melaksanakan proses penandaan sebelum dilakukannya tindakan, dan melibatkan pasien dalam prosesnya.

Semoga dengan adanya Panduan Sisi Yang benar, Prosedur Yang Benar, Pasien Yang Benar Pada Pembedahan/ Tindakan Invasif, dapat digunakan sebagai panduan atau acuan bagi seluruh staf rumah sakit terutama PPA dalam melakukan tindakan operasi/ invasif.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 1 Juli 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah